

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

EGS-R · ESCALA DE GRAVEDAD DE SÍNTOMAS DEL TEPT-REVISADA

Evaluación de la gravedad sintomática y diagnóstico del Trastorno de Estrés Postraumático según criterios DSM-5

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático según el DSM-5 (EGS-R)
Autores Originales	Enrique Echeburúa, Pedro J. Amor, Begoña Sarasua, Irene Zubizarreta, F. Javier Holgado-Tello y José M. Muñoz (2016)
Procedencia y Ámbito	Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y UNED (España). Diseñada originalmente en español.
Tipo de Instrumento	Entrevista estructurada / autoinforme guiado de evaluación clínica y psicométrica
Población Diana	Adultos y adolescentes expuestos a traumas graves (violencia de género, agresiones, accidentes, terrorismo)
Tiempo de Aplicación	10 a 15 minutos (21 ítems clínicos de gravedad)
Formato de Respuesta	Escala Likert de 4 puntos: 0 (Nada) a 3 (Gravemente / 5 o más veces por semana)
Finalidad Clínica	Diagnóstico nosológico categorial según DSM-5 y gradación dimensional de severidad psicopatológica

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La publicación del DSM-5 supuso una reformulación estructural trascendental del TEPT: el trastorno abandonó la categoría de trastornos de ansiedad para ubicarse en los “Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés”, reemplazando la tríada tradicional por un modelo tetrafactorial de 20 síntomas diagnósticos que incluye alteraciones cognitivas y afectivas negativas, además de un subtipo disociativo. Ante esta actualización nosológica, Echeburúa y su equipo desarrollaron la EGS-R como evolución directa de su ampliamente validada Escala de Gravedad de Síntomas del TEPT (EGS de 1997).

La EGS-R está estructurada en 4 secciones que corresponden exactamente a los clústeres del DSM-5: Criterio B (Intrusión: 5 síntomas), Criterio C (Evitación: 2 síntomas), Criterio D (Alteraciones cognitivas y del estado de ánimo negativas: 7 síntomas) y Criterio E (Alteraciones de la alerta y reactividad: 6 síntomas), incorporando un reactivo adicional (ítem 21) para evaluar los síntomas disociativos (despersonalización y desrealización).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Criterio DSM-5	Nº Ítems	Contenido Sintomático Evaluado
Criterio B: Intrusión	5 ítems	Recuerdos intrusivos, pesadillas, reacciones disociativas/flashbacks y malestar intenso.
Criterio C: Evitación	2 ítems	Evitación activa de recuerdos/pensamientos y de factores contextuales externos.
Criterio D: Cognición/Ánimo	7 ítems	Amnesia disociativa, creencias catastróficas, culpa, emociones negativas y desapego.
Criterio E: Reactividad/Alerta	6 ítems	Irritabilidad/ira, imprudencia, hipervigilancia, sobresalto, desconcentración e insomnio.
Especificador Disociativo	1 ítem	Ítem 21: Presencia de despersonalización y/o desrealización persistente.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · EGS-R

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach global sobresaliente = 0.91 a 0.93 en víctimas de violencia y traumas interpersonales en España (Echeburúa et al., 2016). Subescalas: B (0.83), C (0.75), D (0.85), E (0.81).
Fiabilidad Test-Retest	Coeficiente de correlación intraclase $r = 0.89$ tras intervalo de 10 a 14 días en condiciones clínicas basales.
Validez Diagnóstica (ROC)	Con punto de corte global de 19 puntos: Sensibilidad = 89.2%, Especificidad = 88.7%, Área Bajo la Curva ROC = 0.932 frente a la CAPS-5.
Validez Convergente	Correlación elevada con la Escala de Inadaptación ($r = 0.74$), BDI-II ($r = 0.78$) y STAI-Estado ($r = 0.76$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

- Gradación de Cada Ítem (0 a 3):** 0 = Nada; 1 = Una vez por semana o de forma leve; 2 = De 2 a 4 veces por semana o de forma moderada; 3 = 5 o más veces por semana o muy intensamente.
- Criterio de Presencia de Síntoma:** Un síntoma se considera clínicamente presente si el paciente puntúa ≥ 2 (o ≥ 1 en ítems específicos de evitación y amnesia según criterio clínico).
- Diagnóstico Categorical DSM-5:** Requiere verificar la presencia de:
 - Al menos 1 síntoma en Criterio B (Ítems 1-5).
 - Al menos 1 síntoma en Criterio C (Ítems 6-7).
 - Al menos 2 síntomas en Criterio D (Ítems 8-14).
 - Al menos 2 síntomas en Criterio E (Ítems 15-20).
- Puntuación Dimensional Global:** Suma de los ítems 1 al 20 (Rango: 0 a 60 puntos). El ítem 21 (disociación, 0-3) se computa aparte para el especificador.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación EGS-R	Estratificación	Probabilidad TEPT	Significado Clínico y Recomendación
0 a 14 puntos	No Caso / Mínimo	Muy Baja (< 8%)	Reacción adaptativa de estrés. Seguimiento preventivo.
15 a 18 puntos	Sintomatología Subclínica	Moderada (35%)	Síntomas postraumáticos parciales; apoyo psicológico breve.
19 a 34 puntos	TEPT Clínico Moderado	Alta (Corte Oficial 89%)	Cuadro sindrómico de TEPT. Psicoterapia focalizada en trauma.
35 a 60 puntos	TEPT Grave / Invalidante	Extrema (> 95%)	Afectación global grave; abordaje combinado intensivo.

PUNTO DE CORTE CLÍNICO EN ESPAÑA (EGS-R ≥ 19): El umbral dimensional de 19 puntos maximiza la sensibilidad y especificidad diagnóstica. Para la validez pericial forense y clínica se exige cumplir simultáneamente la regla de corte dimensional (≥ 19) y los criterios categoriales de clústeres sintomáticos DSM-5.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · EGS-R

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Delimitación del Suceso Traumático Índice: Asegurar que el suceso reúne los requerimientos del Criterio A (muerte real o amenaza, lesiones graves o violencia sexual).

Paso 2: Evaluación Diagnóstica y Dimensional:

- Si EGS-R < 19 y no cumple criterios DSM-5: Sintomatología adaptativa. Psicoeducación y pautas de autocuidado.
- Si EGS-R ≥ 19 y cumple clústeres B, C, D, E:
 1. Verificar si ítem 21 ≥ 2 (Subtipo disociativo presente): iniciar con técnicas de conexión a tierra (**grounding**) antes de la exposición.
 2. Iniciar Terapia de Procesamiento Cognitivo (CPT), Exposición Prolongada o EMDR.
 3. Si coexiste depresión severa o insomnio incapacitante, pautar sertralina o paroxetina.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Mujer de 34 años, víctima de violencia de género continuada, atendida en un centro de atención a la mujer tras obtener orden de alejamiento hace 2 meses.

Evaluación Psicométrica Inicial: EGS-R Total = 41 / 60 puntos (TEPT Grave).

- **Intrusión (B):** 12 / 15 puntos. Recuerdos dolorosos diarios (ítem 1 = 3) y pesadillas terroríficas (ítem 2 = 3).
- **Evitación (C):** 6 / 6 puntos. Evitación total de conversaciones y lugares asociados a la expareja.
- **Cogniciones y Estado de Ánimo (D):** 13 / 21 puntos. Creencias de culpa ("yo tuve la culpa por permitirlo") y anhedonia.
- **Alerta y Reactividad (E):** 10 / 18 puntos. Hipervigilancia extrema al caminar por la calle y sobresalto continuo.
- **Ítem 21 (Disociación):** 2 puntos (Presencia de despersonalización episódica).

Intervención: Cumple criterios DSM-5 con subtipo disociativo. Se inició terapia cognitivo-conductual centrada en trauma (TCC-CT) combinada con reestructuración de la culpa desadaptativa y entrenamiento en habilidades de estabilización emocional. A las 16 semanas de tratamiento, la EGS-R descendió a 12 puntos, remitiendo las pesadillas y el aislamiento social.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD

- Pacientes con puntuaciones > 35 presentan tasas elevadas de conductas autolíticas; evaluar ideación suicida de forma obligatoria.
- En casos forenses, verificar consistencia temporal para descartar simulación o sobreestimación de secuelas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Trastorno de Estrés Agudo:** El cuadro clínico dura menos de un mes tras el suceso traumático.
- **TEPT Complejo (CIE-11):** Coexiste alteración severa de la autoorganización (desregulación afectiva, autoconcepto negativo y dificultades relacionales crónicas).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Echeburúa, E., Amor, P. J., Sarasua, B., Zubizarreta, I., Holgado-Tello, F. J., & Muñoz, J. M. (2016). Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático según el DSM-5 (EGS-R): Propiedades psicométricas. *Terapia Psicológica*, 34(2), 111–128.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). APA.
- Echeburúa, E., Corral, P., Amor, P. J., Zubizarreta, I., & Sarasua, B. (1997). Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático: Propiedades psicométricas. *Análisis y Modificación de Conducta*, 23(90), 503–526.
- Weathers, F. W., Bovin, M. J., Lee, D. J., Sloan, D. M., Schnurr, P. P., Kaloupek, D. G., ... & Marx, B. P. (2018). The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5): Development and initial psychometric evaluation in military veterans. *Psychological Assessment*, 30(3), 383–395.